

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Carmustine(BCNU) 7.7mg/웨이퍼 (글리아텔웨이퍼, 바이오프로파마슈티칼코리아(주))

☐ 제형, 성분·함량 :

- 이식정제(웨이퍼), 웨이퍼(200mg) 중 carmustine(BCNU) 7.7mg

☐ 효능 효과 :

- 외과적 절제를 해야 하는 재발성 다형성교모세포종(GBM) 환자에서 수술시에 보조제로 사용되어 환자의 생존을 연장한다.

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의 일

2007년 제4차 약제급여평가위원회 : 2007년 5월 18일

2007년 제5차 약제급여평가위원회 : 2007년 6월 15일

- 암질환심의위원회 심의일 : 2007년 4월 18일

2007년 제10차 약제급여평가위원회 : 2007년 10월 19일 [재평가]

- 암질환심의위원회 심의일(재심의) : 2007년 10월 10일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 1차 심의결과(2007년 4차 약제급여평가위원회)

○ 재심의

- 신청품은 ‘재발성 다형성교모세포종 환자’만에 허가된 반면 기존 약제인 테모달갑셀(temozolomide)은 ‘재발성’뿐만 아니라 ‘새로이 진단된 다형성 교아종’에 허가된 점을 고려하여, 테모달갑셀(temozolomide)을 새로이 진단된 경우에 사용했던 환자가 다시 재발한 경우의 치료법 및 비용효과성에 대한 자료 보완 이후 재심의하는 것으로 평가됨.

□ 2차 심의결과(2007년 제5차 약제급여평가위원회)

○ 비급여

- 신청품은 재발성 다형성 교모세포종 환자의 수술시 보조제로 허가를 받았으나, 현재 급여목록에 등재되어 있는 대상 질환의 치료약제인 temozolomide cap.과의 간접비교시, 6개월 생존율 및 생존기간(median survival)이 낮은 반면, 투약비용이 고가인 점을 고려할 때 비용효과성이 불분명하므로 비급여 함.

□ 재평가 심의결과(2007년 제10차 약제급여평가위원회)

○ 비급여

- 제약사에서 판매예정가를 인하하였으나, 급여를 요청한 “테모달 투여 후 재발 환자”에 대한 신청품의 의학적 근거가 불충분하여, 기심의결과(비급여)를 유지기로 함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 관련 임상진료지침에서는 종양이 국소적으로 재발한 경우로 수술이 가능한 경우, 수술과 함께 BCNU(신청품)을 삽입하는 치료법과, 수술후 방사선치료 또는 전신화학요법을 실시하는 치료법을 모두 함께 권고하고 있으며¹⁾
- 재발인 경우 BCNU 삽입을 임상평가중인 치료법으로 언급되고 있으므로²⁾
- 임상지침에서 신청품 대상환자인 종양이 국소적으로 재발한 환자에 대해 신청품 사용을 선택적(임상지침별로 권고하거나 치료적 옵션으로 제시함)으로 제시하고 있다고 볼 수 있음.

○ 임상적 유용성

- 재평가 요청시 추가 제출된 자료 및 검색된 임상 문헌은 없었음.
- 교과서 및 임상지침에서는 temozolomide 치료 이후 재발한 경우에 대한 언급은 없었으며, 문헌³⁾에서는 신규환자에서 표준요법은 temozolomide요법으로 초기에 방사선요법을 병용하는 것이며, 2차 약제로는 nitrosourea제제가 가장 흔하게 사용되는 약제이며, carboplatin, etoposide, irinotecan 및 이들의 병용요법도 흔하게 사용된다

고 함.

- temozolomide 투여 후 재발환자에 대한 신청품의 임상시험 결과가 없으며, 신청품 3상 임상시험 대상 환자의 1차 치료법에 대해 자세히 설명되지 않아, 제약사에서 제시한 temozolomide 투여 후 재발 환자에 대한 신청품의 임상적 유용성을 판단하기 곤란함.

암질환심의위원회 재심의 결과, 급여인정을 요청한 “테모달 투여 후 재발한 환자”에 현재로서는 급여로 인정하여야 할 만한 의학적 타당성이 없는 것으로 심의됨.

○ 비용 효과성

- 삶의 질을 고려한 비용효과성을 제약사가 소명하지 못함.

○ 보험재정에 미치는 영향

- 신청품 1회 이식이 temozolomide cap. 3개월, 6개월 투여를 대체하는 경우 모두 소요비용이 증가됨.
- 신청품 임상시험⁴⁾에서 이식 6개월 이내 전신 화학요법을 받은 환자가 carmustine polymer 이식군에서 25.5%이었음을 고려 시 전신 화학요법제의 소요비용이 추가되는 경우 재정부담은 더 커질 수 있을 것으로 사료됨.

○ 제 외국 등재 현황

- 미국, 호주, 영국, 독일, 네델란드, 프랑스, 스페인 등에 허가되어 있으며,
- 호주 PBS(Schedule of Pharmaceutical Benefits)에서는 최초 수술 시에 한하여 급여되고 있으나, 재발성 환자의 경우는 제약사의 급여요청을 2차례 기각한 바 있음.
- 영국 NICE(National Institute for Health and Clinical Excellence)의 경우, 신규진단 환자 중에서 종양이 90%이상 절제된 환자에 제한적으로 추천하고 있음.⁵⁾

Reference

- 1) NCCN; National Comprehensive Cancer Network, practice guidelines in Oncology v2. 2006,
- 2) ESMO; European Society for Medical Oncology, Esmo Minimum Clinical Recommendations for diagnosis, treatment and follow-up of malignant glioma(annals of oncology 18(Supplement 2): ii69-ii70, 2007)
- 3) Nicholas A. Butowski et al, Diagnosis and treatment of recurrent high-grade astrocytoma, *JCO* 2006;24:1273-80.
- 4) H. Brem et al, Placebo-controlled trial of safety and efficacy of intraoperative controlled delivery by biodegradable polymers of chemotherapy for recurrent glioma, *Lancet* 1995;345:1008-12.
- 5) NICE technology appraisal guidance 121, June 2007).